Клинические рекомендации

# Наружный отит у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **H60.0** — Абсцесс наружного уха<br>**H60.1** — Целлюлит наружного уха<br>**H60.2** — Злокачественный наружный отит<br>**H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты<br>**H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный<br>**H60.8** — Другие наружные отиты<br>**H60.9** — Наружный отит неуточненный<br>**H61.0** — Перихондрит наружного уха<br>**H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха<br>**H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная<br>**H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках<br>**H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках<br>**H62.2** — Наружный отит при микозах<br>**H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках<br>**H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках<br>**H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| Пациенты | дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года |
| Разработчик | Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/21_3 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** ..... 3

**2. Клиническая картина и классификация** ..... 3

2.1 Определение ..... 3

2.2 Классификация ..... 3

2.3 Этиология ..... 4

2.4 Клиническая картина ..... 4

**3. Диагностика** ..... 6

3.1 Жалобы 7
3.2 Отоскопия 7
3.3 Микробиологическое исследование отделяемого из уха 7
3.4 Анализы крови 7
3.5 Рентгенография или КТ височной кости 8
3.6 МРТ височных костей и основания черепа 8
3.7 Консультации специалистов 8
3.8 Дифференциальная диагностика 8
**4. Лечение 9**
4.1 Неосложнённый наружный отит 9
4.2 Системная антибактериальная терапия 11
4.3 Грибковый наружный отит 11
4.4 Злокачественный наружный отит 12
4.5 Хирургическое лечение 12
4.6 Физиотерапия 12
**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12**
5.1 Показания к госпитализации 12
5.2 Критерии выписки 13
5.3 Профилактика 13
**6. Источник и актуальность 13**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

## 1. Основные положения

- Наружный отит: воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки. Формы по течению:
  1. острая: **до 6 недель**;
  2. хроническая: симптомы **более 3 месяцев** или **более 4 эпизодов в год**.
- Критерии диагноза:

  **Обязательный критерий**

  1. признаки воспаления слухового прохода: болезненный козелок и (или) ушная раковина, или диффузный отёк, или гиперемия слухового прохода.

  **Возможные признаки**

  1. оторея;
  2. регионарная аденопатия;
  3. эритема барабанной перепонки или целлюлит ушной раковины и прилегающей кожи;
  4. боль в ухе, иногда с иррадиацией в челюсть;
  5. зуд или ощущение распирания в ухе.
- Основу лечения составляет местная терапия ушными каплями, активными против синегнойной палочки и золотистого стафилококка. Эффект оценивают **через 48–72 часа**, курс в среднем **7–10 дней** (до 14).
- При неосложнённом наружном отите системные антибактериальные препараты не назначают: они неэффективны.
- Лечение, как правило, амбулаторное. Госпитализации подлежат дети в тяжёлом состоянии; неэффективность лечения, подозрение на прогрессирование и осложнения требуют консультации оториноларинголога и госпитализации.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определение

Наружный отит (НО): воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода (НСП) и эпидермального слоя барабанной перепонки.

### 2.2 Классификация

**По течению**

1. острая форма: **до 6 недель**;
2. хроническая форма: симптомы сохраняются **более 3 месяцев** или **более 4 эпизодов** наружного отита в год.

**Нозологические формы**

1. диффузный наружный отит;
2. ограниченный наружный отит: фурункул, абсцесс;
3. экзема и дерматит;
4. рожистое воспаление;
5. перихондрит;
6. герпетическое поражение;
7. грибковый наружный отит;
8. злокачественный наружный отит.

Злокачественный наружный отит (ЗНО): наиболее тяжёлая форма, для которой характерно быстро прогрессирующее течение с распространением процесса за пределы ушной раковины, слухового прохода и наружного уха.

### 2.3 Этиология

Воспалению предшествует нарушение целостности кожи.

**Причины и предрасполагающие факторы**

1. травматические повреждения;
2. длительное пребывание во влажной среде, попадание воды в уши;
3. изменения кожи при нарушении обмена веществ, сахарном диабете, дерматитах, экземе;
4. узкие наружные слуховые проходы, экзостозы;
5. ношение слухового аппарата, наушников;
6. недостаточное образование или изменение состава ушной серы;
7. нарушение местного и общего иммунного статуса;
8. лучевое воздействие.

Ведущие возбудители у детей: синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus); также P. vulgaris и E. coli.

**Частота бактериальной природы и выделения возбудителей**

1. воспалительные заболевания наружного уха имеют бактериальную природу в 60–98%;
2. P. aeruginosa выделяют в 20–60%, S. aureus в 10–70%;
3. анаэробные штаммы встречаются в 4–25%;
4. смешанная флора — в трети случаев.

Грибковый наружный отит у детей не редкость: в России более 20% поражений наружного уха. Основные возбудители: плесневые грибы Aspergillus и Penicillium, дрожжеподобные грибы Candida. Часто выделяют грибково-бактериальные ассоциации с синегнойной палочкой, стрептококками и стафилококками.

**Факторы развития микоза**

1. травматическое повреждение кожи;
2. нарушение обмена веществ и гормонального баланса;
3. иммунодефицит;
4. длительное применение системных антибактериальных препаратов и кортикостероидов.

### 2.4 Клиническая картина

**Диффузный наружный отит**, острая форма.

**Отоскопия**

1. отёк и гиперемия кожи НСП, выделения вязкого секрета;
2. барабанная перепонка может быть не видна из-за отёка стенок слухового прохода в хрящевом и костном отделах;
3. детрит в НСП.

**Симптомы**

1. болезненность в области НСП, усиливается при оттягивании ушной раковины или надавливании на козелок;
2. возможна лихорадка до фебрильных цифр;
3. болезненность и ограничение движений в височно-нижнечелюстном суставе при открывании рта;
4. увеличение и болезненность заушных лимфатических узлов («псевдомастоидит»).

**Хроническая фаза**: утолщение кожи из-за инфильтрации или фиброза, мирингит. Кондуктивное снижение слуха при значительном сужении или обтурации слухового прохода отделяемым.

**Фурункул слухового прохода** (ограниченный наружный отит).

**Отоскопия**

1. сужение просвета очерченным конусовидным или округлым возвышением с локальной гиперемией;
2. стадия инфильтрации (**1–3-и сутки**): локальное уплотнение кожи;
3. стадия абсцедирования: просвечивающая гнойная головка;
4. после самопроизвольного вскрытия: кратерообразное углубление с гноем.

**Симптомы**

1. боль в ухе, усиливается при оттягивании раковины или надавливании на козелок;
2. иррадиация в зубы, глаз, шею, околоушную область, глотку;
3. инфильтрация может распространяться на мягкие ткани, сосцевидный отросток и веки;
4. фурункул задней стенки: возможны кашель и рвота (раздражение ветвей блуждающего нерва);
5. фурункул передней или нижней стенки: воспаление околоушной железы;
6. увеличенные, плотные, болезненные регионарные лимфатические узлы;
7. возможна фебрильная лихорадка;
8. кондуктивное снижение слуха при значительном сужении слухового прохода.

**Экзема и дерматиты**.

**Острая экзема**

1. гиперемия и инфильтрация кожи раковины и НСП;
2. везикулёзно-пустулёзная сыпь на отёчном основании, мокнутие, серо-жёлтые корки;
3. выраженный зуд;
4. вторичная инфекция ведёт к ограниченному или диффузному наружному отиту.

**Хроническая экзема**

1. зуд;
2. утолщение кожи;
3. шелушение, трещины, мокнутие.

**Рожистое воспаление**.

1. выраженная гиперемия и припухлость кожи раковины, включая мочку, с линией демаркации за пределами раковины;
2. жжение и резкая болезненность при пальпации;
3. интоксикация (озноб, головная боль), лихорадка **до 39–40 °C**;
4. при буллёзной форме пузыри с серозным содержимым.

**Перихондрит ушной раковины**: мочка уха не вовлечена.

1. выраженная боль в раковине с возможной иррадиацией в голову или шею;
2. отёк, гиперемия, сглаженность контуров раковины;
3. резкая болезненность при пальпации;
4. гной между надхрящницей и хрящом, флюктуация;
5. интоксикация;
6. при позднем обращении расплавление хряща, свищи и рубцовая деформация раковины.

**Герпетическое поражение**.

1. множественные сгруппированные пузырьки на раковине, в НСП, иногда на барабанной перепонке; после вскрытия корочки;
2. резкая боль, покалывание, зуд;
3. возможна интоксикация;
4. в тяжёлых случаях нейросенсорная тугоухость, нарушение равновесия, парез лицевого и тройничного нервов.

**Грибковое поражение**: картина зависит от возбудителя.

1. грудные и ясельные дети: беспокойство, маятникообразные движения головы, расчёсы кожи раковин;
2. старшие дети: жидкие выделения (при кандидозе), корочки, зуд, боль, заложенность и снижение слуха; редко головная боль, лихорадка, чувствительность раковины и заушной области.

| Возбудитель | Картина |
|---|---|
| Candida | 1. гиперемия, инфильтрация и мацерация кожи НСП, гиперемия барабанной перепонки;<br>2. отделяемое менее густое, беловатое;<br>3. на раковине гиперемия с эрозиями, легко снимающиеся беловатые налёты;<br>4. возможен хондроперихондрит с деформацией раковины. |
| Aspergillus | 1. казеозно-некротические массы в просвете;<br>2. инфильтрация сильнее в костном отделе, возможен мирингит;<br>3. беловато-серые наложения с чёрными вкраплениями («молотый перец»);<br>4. Aspergillus glaucus: зеленоватое отделяемое. |
| Penicillium | 1. желтоватое отделяемое, иногда похоже на серу, по всему слуховому проходу;<br>2. инфильтрация кожи, сухие корочки и плёнки. |
| Geotrichum capitatum | 1. выраженная инфильтрация кожи НСП, мирингит;<br>2. плотные «замазкообразные» серовато-жёлтые массы по всему слуховому проходу. |

**Злокачественный (некротизирующий) наружный отит** у детей редок, возможен при иммунодефиците, в том числе при лейкозе после трансплантации костного мозга.

1. интенсивная боль в ухе, головная боль на стороне поражения;
2. системные признаки: интоксикация или лихорадка;
3. возможны болезненность височной кости и парез лицевого нерва;
4. классический симптом: грануляции в костно-хрящевом соединении дна НСП;
5. инфекция распространяется к основанию черепа с остеомиелитом височной кости.

---

## 3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза и физикального обследования с отоскопией. Другие исследования необходимы для выбора лечения, диагностики осложнений и динамического контроля.

### 3.1 Жалобы

**Местные**

1. боль в ухе, может усиливаться при пальпации и жевании;
2. зуд в НСП;
3. выделения из уха;
4. снижение слуха.

**Системные**

1. лихорадка, как правило субфебрильная;
2. ухудшение самочувствия (инфекционный токсикоз).

### 3.2 Отоскопия

**Показания**

1. все пациенты с подозрением на наружный отит.

**Диагностические признаки**

1. болезненность при нажатии на козелок и оттягивании ушной раковины;
2. НСП гиперемирован, как правило сужен отёком;
3. барабанная перепонка видна частично, возможна умеренная гиперемия;
4. при отопневмоскопии подвижность барабанной перепонки, как правило, сохранена.

### 3.3 Микробиологическое исследование отделяемого из уха

**Показания**

1. тяжёлое течение: до начала терапии;
2. рецидивирующий и хронический наружный отит;
3. иммунодефицит: иммунодепрессанты, ВИЧ-инфекция, химио- или лучевая терапия;
4. инфекция после операции на ухе;
5. нет ответа на начальную терапию.

Посев на аэробы и факультативные анаэробы с определением чувствительности, микроскопия и посев на дрожжевые и мицелиальные грибы.

**Забор материала**

1. до начала антимикробной терапии;
2. под зрительным контролем;
3. тонким стерильным зондом-тампоном из просвета или со стенок НСП, не касаясь дистальных отделов наружного уха.

При необходимости контроля или без эффекта исследование повторяют.

### 3.4 Анализы крови

Рутинно не проводят: лабораторных исследований, подтверждающих диагноз, нет.

**Показания**

1. все госпитализированные, в том числе со злокачественным наружным отитом: развёрнутый общий анализ крови и С-реактивный белок.

### 3.5 Рентгенография или КТ височной кости

**Показания**

1. подозрение на злокачественный наружный отит или деструктивный процесс: рентгенография или КТ височных костей, при необходимости с контрастированием.

**Диагностические признаки**

1. деструкция височной кости и основания черепа для наружного отита не характерна, кроме злокачественного.

### 3.6 МРТ височных костей и основания черепа

**Показания**

1. подозрение на распространение воспаления на окружающие мягкие ткани: уточнение диагноза, распространённости и тактики.

Наркоз по показаниям.

### 3.7 Консультации специалистов

При поражении наружного уха на фоне системных, в том числе инфекционных, заболеваний показаны консультация профильного специалиста и обследование по соответствующим КР. Консультацию проводит:

1. детский онколог;
2. инфекционист;
3. аллерголог-иммунолог;
4. детский эндокринолог;
5. невролог;
6. дерматовенеролог.

### 3.8 Дифференциальная диагностика

Проводят всем с подозрением на наружный отит, в том числе при оторее.

| Заболевание | Отличия от наружного отита |
|---|---|
| **Средний отит** | 1. перфорация барабанной перепонки: диагноз наружного отита сомнителен, вероятен очаг в среднем ухе со вторичным воспалением НСП. |
| **Мастоидит** | 1. сглаженность заушной складки;<br>2. изменения больше в заушной области, в проекции антрума;<br>3. на рентгенограмме или КТ: снижение воздушности, нарушение структуры и целостности клеток сосцевидного отростка. |
| **Гнойный паротит** | 1. припухлость и болезненность книзу и кпереди от НСП (проекция околоушной железы);<br>2. обильное гноетечение из уха при прорыве абсцесса через санториниевы щели. |
| **Отомикоз** | 1. налёты и наложения на коже НСП: тёмный налёт как угольная пыль или «мокрая газетная бумага» (Aspergillus niger), белесоватые хлопья (Candida albicans);<br>2. предрасполагают влажность и микротравмы, может быть осложнением антибактериальной терапии;<br>3. подтверждается микробиологическим исследованием. |

Особенно важно дифференцировать **злокачественный наружный отит**.

**Признаки злокачественного наружного отита**

1. грануляции в слуховом проходе;
2. микроабсцессы в области наружного уха и основания черепа;
3. костная деструкция по лучевым методам;
4. нет эффекта консервативной терапии **более одной недели**.

**Отягощающие факторы**

1. сахарный диабет;
2. нейропатии черепных нервов;
3. истощение.

Отсутствие положительной динамики **в течение 1–3 недель** свидетельствует в пользу ЗНО.
Подтверждение: КТ или МРТ (остеомиелит основания черепа), дополнительно маркеры воспаления: нейтрофильный лейкоцитоз, повышение С-реактивного белка.

---

## 4. Лечение

### 4.1 Неосложнённый наружный отит

#### Местная терапия

Всем пациентам с установленным наружным отитом назначают ушные препараты: противомикробные, кортикостероиды, их комбинации, анальгетики и анестетики.

Препарат должен действовать на синегнойную палочку и золотистый стафилококк. Эффект оценивают **через 48–72 часа**, длительность лечения в среднем **7–10 дней** (до 14).

Препараты из таблицы предназначены для начальной местной терапии неосложнённого наружного отита: безопасны и эффективны, осложнения практически не возникают.

Местная терапия создаёт оптимальную концентрацию в очаге, почти не всасывается и реже ведёт к отбору устойчивых штаммов.

**Препараты для местного лечения у детей**

| Препарат | Компоненты | Возрастные ограничения |
|---|---|---|
| **Офлоксацин, капли глазные и ушные** | антибактериальный: офлоксацин | с 12 лет; с 1 года при тимпаностомической трубке |
| **Ципрофлоксацин, капли глазные и ушные** | антибактериальный: ципрофлоксацин | с рождения (с 0 лет) |
| **Норфлоксацин, капли глазные и ушные** | антибактериальный: норфлоксацин | с 1 года |
| **Ципрофлоксацин + дексаметазон (Комбинил), капли глазные и ушные** | антибактериальный: ципрофлоксацин; противовоспалительный: дексаметазон | с 1 года |
| **Бетаметазон + гентамицин, капли глазные и ушные** | антибактериальный: гентамицин; противовоспалительный: бетаметазон | с 8 лет |

| Препарат | Компоненты | Возрастные ограничения |
|---|---|---|
| **Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон, капли глазные и ушные** | антибактериальный: грамицидин + фрамицетин; противовоспалительный: дексаметазон | с 1 года |
| **Дексаметазон + неомицин + полимиксин B, капли ушные** | антибактериальный: полимиксин B + неомицин; противовоспалительный: дексаметазон | нет ограничений |
| **Лидокаин + неомицин + полимиксин B, капли ушные** | антибактериальный: полимиксин B + неомицин; анестезирующий: лидокаин | нет ограничений; детям до 1 года только при крайней необходимости и под контролем врача |
| **Рифамицин, капли ушные** | антибактериальный: рифамицин | нет ограничений |
| **Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол, капли ушные** | антибактериальный: хлорамфеникол; противогрибковый: клотримазол; противовоспалительный: беклометазон; анестезирующий: лидокаин | с 6 лет |
| **Миконазол, крем 2%** [2] | противогрибковый: миконазол | нет ограничений |
| **Клотримазол, крем 1%** [1] [2] | противогрибковый: клотримазол | нет ограничений |
| **Натамицин, крем 2%** | противогрибковый: натамицин | нет ограничений |

[1] Клотримазол не активен в отношении Aspergillus. [2] Курс **не менее 10 дней**.

Наружный отит как проявление контактного, атопического или себорейного дерматита, псориаза, системной красной волчанки: лечение по соответствующим КР. При себорейном дерматите возможна инфекция грибами Malassezia: нужна местная противогрибковая и (или) противовоспалительная терапия.

Возможны аллергические реакции на местное лечение, в том числе на препараты с неомицином.

### Туалет наружного слухового прохода

Слуховой проход регулярно и атравматично очищают от серы и экссудата у всех пациентов: экссудат снижает эффективность местного лечения.

Туалет обычно проводит оториноларинголог. После исключения дефекта барабанной перепонки слуховой проход можно осторожно промывать дистиллированной водой или 0,9% раствором натрия хлорида. Ватные палочки применять не следует: микротравмы способствуют инфекции.

### Обезболивание

#### Показания

1. выраженный болевой синдром.

Системно ибупрофен или парацетамол в возрастных дозах и (или) местное обезболивание. Ибупрофен в суспензии разрешён **с 3 месяцев**, у парацетамола есть ограничения для детей младшего возраста. Местное обезболивание может замаскировать прогрессирование: такого пациента наблюдают **48 часов**.

Устранение предрасполагающих факторов ускоряет разрешение воспаления (см. «Этиология»).

### 4.2 Системная антибактериальная терапия

При неосложнённом наружном отите системная антибактериальная терапия не показана: результаты местного лечения в сочетании с системными антибиотиками и с плацебо не различаются.

**Показания**

1. воспаление вышло за пределы НСП: заушный абсцесс, мастоидит;
2. острый средний отит, в том числе у детей младшего возраста;
3. постлучевой наружный отит;
4. злокачественный (некротизирующий) отит;
5. неконтролируемый сахарный диабет;
6. иммуносупрессия;
7. невозможность местной антибактериальной терапии.

Препарат должен действовать на P. aeruginosa и S. aureus.

### 4.3 Грибковый наружный отит

Тщательный туалет НСП является обязательным условием местной противогрибковой терапии; его выполняют аттиковым зондом и ватником с противогрибковым препаратом.

**Кандидозный отит: 1% раствор клотримазола или 1% раствор нафтифина**

1. туалет и аппликации на турундах: 2 раза в сутки, экспозиция до 10 минут;
2. курс в среднем **4 недели**.

**Плесневые и диморфные грибы: 1% раствор нафтифина**

1. туалет и аппликации на турундах: 2 раза в сутки, экспозиция до 15 минут;
2. курс в среднем **4 недели**.

Противогрибковые кремы (миконазол, клотримазол, натамицин) и длительность их применения приведены в таблице «Препараты для местного лечения у детей» и в сносках к ней.

При перфорированной барабанной перепонке грибковое поражение расценивается как системная (инвазивная) инфекция: показан противогрибковый препарат системного действия по данным посева, например флуконазол при кандидозном и итраконазол при аспергиллёзном наружном отите, с учётом возрастных ограничений инструкции.

### 4.4 Злокачественный наружный отит

Доказательных данных о терапии недостаточно. До получения результатов посева применяют препараты, активные против синегнойной палочки.

1. #ципрофлоксацин внутрь: 20–30 мг/кг в сутки в 2 приёма каждые 12 часов, не более 1500 мг в сутки;
2. или парентерально в эквивалентной дозе: антисинегнойные пенициллины, цефалоспорины III или IV поколения с антисинегнойной активностью, с аминогликозидами или без, по чувствительности возбудителя.

Многие штаммы P. aeruginosa устойчивы к ципрофлоксацину из-за его широкого амбулаторного применения. При иной этиологии (Enterobacterales, Aspergillus и другие плесневые грибы, MRSA) назначают соответствующие системные противомикробные препараты.

Курс **4–6–8 недель**, при грибковой этиологии дольше, например **до 12 недель**.

Параллельно проводят местную терапию, возможно применение антисептиков и препаратов йода. При прогрессировании заболевания или плохом ответе на консервативное лечение показано хирургическое лечение, возможно в сочетании с гипербарической оксигенацией.

Во время лечения регулярно контролируют клинику и КТ или МРТ, чтобы оценить ответ и вовремя заметить возобновление; проводят контрольный посев отделяемого. Частота исследований индивидуальна.

### 4.5 Хирургическое лечение

**Показания**

1. устранение причины или осложнения наружного отита.

**Вмешательства**

1. вскрытие и дренирование абсцесса (флегмоны) НСП;
2. иссечение грануляций;
3. секвестрэктомия: удаление костных и хрящевых секвестров;
4. удаление холестеатомы НСП.

Объём в пределах зоны поражения; выполняет оториноларинголог с анестезиологом-реаниматологом.

### 4.6 Физиотерапия

Избирательно, как дополнительное лечение, применяют низкочастотное магнитное поле, низкоинтенсивное лазерное излучение эндоаурально, короткое ультрафиолетовое облучение наружного уха. Убедительных доказательств эффективности нет.

---

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

### 5.1 Показания к госпитализации

Лечение в большинстве случаев амбулаторное. При бактериальном наружном отите улучшение наступает **через 12–24 часа** после начала антибактериальной терапии.

**Показания к госпитализации**

1. тяжёлое состояние ребёнка;
2. неэффективность лечения;
3. подозрение на прогрессирование воспаления;
4. развитие осложнений.

При неэффективности, прогрессировании и осложнениях необходима консультация оториноларинголога, при злокачественном отите также детского онколога и других специалистов.

Злокачественный наружный отит требует стационарного лечения.

### 5.2 Критерии выписки

1. устойчивое купирование проявлений болезни;
2. отсутствие угрозы жизни и здоровью пациента.

**Осложнения нелеченого или неадекватно леченого отита**

1. переход в хроническую форму с обострениями при неблагоприятных факторах;
2. разрушение хрящевой и костной ткани НСП;
3. распространение на прилегающие ткани и органы.

### 5.3 Профилактика

**Не допускать травм и переувлажнения НСП**

1. периодически обрабатывать антисептиком наушники, ушные вкладыши слуховых аппаратов и беруши;
2. пользоваться только своими наушниками, вкладышами и берушами;
3. ограничить время в наушниках;
4. не использовать ватные палочки;
5. избегать жёстких многоразовых берушей;
6. высушивать слуховой проход после попадания воды, в том числе феном.

Детям **старше 2 лет**: своевременное удаление ушной серы как возможной причины острого наружного отита.

Медицинская реабилитация не требуется.

Диспансерное наблюдение не требуется.

Прогноз в большинстве случаев благоприятный.

---

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Наружный отит» |
| Версия | 3-я, опубликована в рубрикаторе 18.12.2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года |
| Код в рубрикаторе | 21_3 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; МАКМАХ |
| Пациенты | Дети |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.